

보건복지부 고시 제2026-69호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2026-42호(2026. 2. 25.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 3월 26일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 "[129] Vutrisiran sodium 주사제(품명: 암부트라프리필드시린지주), [214] Macitentan + Tadalafil 복합경구제(품명 : 읍신비정), [259] Solifenacin succinate 6mg, Tamsulosin hydrochloride 0.4mg 복합경구제(품명:메숨니서방정), [339] Vadadustat 경구제(품명: 바다넙정 150mg 등), [399] Dantrolene 주사제(품명: 아길러스주 120mg 등)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준, [일반원칙] 폐동맥고혈압약제, [119] Ocrelizumab 주사제(품명 : 오크레부스주), [142] Tocilizumab 주사제(품명 : 약템라주, 약템라피하주사 162밀리그램 등), [219] Tafamidis 경구제(품명: 빈다맥스캡슐61밀리그램), [249] Darbepoetin alpha 주사제(품명: 네스프프리필드시린지주 등), [249] Erythropoietin 주사제(품명: 에포카인주 등), [249] Methoxy polyethylene glycol-epoetin β 주사제(품명: 미세라프리필드주), [439] Faricimab 주사제(품명: 바비스모주)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 4월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[129] 기타의 말초신경용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[129] Vutrisiran sodium 주사제 (품명: 암부트라프리필드시린지주)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 말초 또는 자율 신경병증의 증상이 있는 트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증(TTR-FAP: Transthyretin Familial Amyloid Polyneuropathy) 환자 중 1) 또는 2)에 해당하면서 다음 조건을 모두 만족하는 경우 1) 1단계* 환자 중 Tafamidis meglumine 투여에도 효과가 불충분하거나 금기 또는 부작용 등으로 투여가 불가능한 경우 2) 2단계* 환자 - 다 음 - 1) 조직검사에서 아밀로이드 침착 확인	○ Vutrisiran sodium (품명 : 암부트라프리필드시린지주)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가 결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함

		2) 유전자검사에서 트랜스티레틴 유전자의 변이 확인 ※ TTR-FAP stages of disease(ATTReUNET) Stage 0 - Asymptomatic Stage 1 - Mild, ambulatory, symptoms at lower limbs limited Stage 2 - Moderate, further neuropathic deterioration, ambulatory but requires assistance Stage 3 - Severe, bedridden/wheelchair-bound with generalized weakness 나. 제외대상 1) 간이식을 받은 경우 2) NYHA(New York Heart Association) class > II 다. 평가방법 6개월 간격으로 질병 Stability에 대한 평가(NIS-LL, mBMI, PND score 등)를 시행하여야 함. 라. 중지기준 1) 평가 결과 2회 연속 직전 NIS-LL 점수보다 2점 이상 악화된 경우 2) 3단계*로 진행된 경우 2. 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드증(hATTR)에 Tafamidis 경구제(품명: 빈다맥스캡슐61밀리그램)와의 병용투여는 인정하지 아니함. 3. 동 약제는 최초 투여 시 투여대상, 지속투여 및 투여중단 시 반응평가	
--	--	--	--

		등에 대한 객관적 자료(진료기록부, 조직검사결과지, 유전자검사지 등)를 반드시 제출하여야함. 4. 암부트라프리필드시린지주의 사후관리를 위한 방법·절차 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.	
※ 관련근거 1) Current Medical Diagnosis & Treatment 2025 2) Quick Medical Diagnosis & Treatment 2025 3) Diagnosis and treatment of hereditary transthyretin amyloidosis with polyneuropathy in the United States: Recommendations from a panel of experts (2024) 4) Canadian Guidelines for Hereditary Transthyretin Amyloidosis Polyneuropathy Management (2022) 5) Recommendations update for the diagnosis and treatment of transthyretin variant amyloidosis (ATTRv) Medicina Clínica (2024) 6) Expert consensus recommendations to improve diagnosis of ATTR amyloidosis with polyneuropathy Journal of Neurology (2021) 7) First European consensus for diagnosis, management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy (2016) 8) David Adams et al. Efficacy and safety of vutrisiran for patients with hereditary transthyretin-mediated amyloidosis with polyneuropathy: a randomized clinical trial The Journal of Protein Folding Disorders 2023;30(1):18-26. 9) Marco Luigi et al. Impact of Baseline Neuropathy Severity on Vutrisiran Treatment Response in the Phase 3 HELIOS-A Study Neurology and Therapy 2024;113:625-639 10) Laura Obici et al. Impact of Vutrisiran on Quality of Life and Physical Function in Patients with Hereditary Transthyretin-Mediated Amyloidosis with Polyneuropathy Neurology and Therapy 2023;12:1759-1775. 11) Madeline Merkel et al. Indirect treatment comparison (ITC) of the efficacy of vutrisiran and tafamidis for hereditary transthyretinmediated amyloidosis with polyneuropathy Expert Opinion on Pharmacotherapy 2023;24(10);pages 1205-1214. 12) 대한신경과학회(대신학 제2025-400호, 2024.2.17.) 13) 대한신경근육질환학회(대신근 제2025-001호, 2024.2.4.) 14) NICE (2023.2.15.) 15) SMC (2023.9.11.) 16) CAD-AMC(2024.2.15.)			

[214] 혈압강하제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[214] Macitentan + Tadalafil 복합경구 제 (품명 : 옵신비정)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 [일반원칙] 폐동맥고혈압약제 “세부사항” 및 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상: 다음을 모두 만족하는 경우 1) WHO 기능분류 단계 III 에 해당하는 폐동맥 고혈압 환자(WHO Group I)로 진단이 확인된 환자 2) ERA계 또는 PDE5i계 약제를 급여로 단독투여하던 환자 또는 폐동맥 고혈압 약물치료 경험이 없는 환자 나. 투여방법: ○ 병용요법 대상환자 및 [일반원칙] 폐동맥고혈압약제 “세부사항” 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함.	○ Macitentan + Tadalafil 복합경구제(품명 : 옵신비정)가 신규 등재예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

		2. 치료 효과에 대해 정기적인 평가가 이루어져야 하며, 허가사항 중 주의사항(약물상호작용, 부작용 등), 금기환자 등을 확인하여 투여하여야 함.	
※ 관련근거 · FDA(2021.), MHRA(2023.), 캐나다(2023.), PMDA(2024.), TGA(2024) · Canada(2021.), FDA(2024.), EMA(2024.) · Current Medical Diagnosis & Treatment 2025 · Goldman-Cecil 27e.(2024.) · Goodman & Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics 14th edition.(2023.) · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd Edition.(2025.) · 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension · Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension in Adults (2019.) · 2020년 폐고혈압 진료지침: 대한심장학회, 대한결핵 및 호흡기학회 · Ekkehard Grünig et al. Randomized Trial of Macitentan/Tadalafil Single-Tablet Combination Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension. J Am Coll Cardiol. 2024;83:473–484). · Grill S et al. Bioequivalence of macitentan and tadalafil given as fixed-dose combination or single-component tablets in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2020 DEC;86:2424–2434. · Dénes Csonka et al. Bioequivalence and food effect of a fixed-dose combination of macitentan and tadalafil: Adaptive design in the COVID-19 pandemic. Pharmacol Res Perspect. 2021 Oct;9:e00846. · Jennifer Lynn Ford et al. Bioequivalence and the food effect of macitentan/tadalafil 10/20 fixed-dose combination tablets versus the use of single-component tablets in healthy subjects. Pharmacol Res Perspect. 2024 Jun;12:e1202. · Maja Petrovič et al. A Bayesian Network Meta-analysis of Add-on Drug Therapies Specific for Pulmonary Arterial Hypertension. Annals of Pharmacotherapy 2020 May. 54(5) 423–433. · CADTH(2022.), PBAC(2024.)			

[259] 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[259] Solifenacin succinate 6mg, Tamsulosin hydrochloride 0.4mg 복합경구제 (품명:베숨니서방정)	<신 설>	허가사항 범위(성인 남성에서 탐스로신 단독요법에 적절히 반응하지 않는 양성 전립샘비대증에 따른 중등도 내지 중증 저장증상(빈뇨, 요절박) 및 배뇨증상의 치료) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함.	○ ‘베숨니서방정’ 1품목이 신규 등재 예정임에 따라, 국내외 허가사항, 관련문헌(교과서, 임상진료지침, 임상연구문헌) 및 학회의견(전문가의견) 등을 고려하여 급여기준을 신설함

※ 관련근거

1. Campbell-Walsh-Wein Urology, 13e. 2025, Chapter 150 Evaluation and Nonsurgical Management of Benign Prostatic Hyperplasia
2. Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2023, Chapter: 114 Benign Prostatic Hyperplasia and Prostatitis
3. 전립선비대증 진료권고안, 대한비뇨기과학회, 2015
4. MANAGEMENT OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS ATTRIBUTED TO BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: AUA GUIDELINE (Published 2021; Amended 2023)
5. EAU Guidelines on Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)(2025)
6. 신경인성방광 지침서, 대한배뇨장요실금학회, 2011
7. EAU Guidelines on Neuro-Urology(2024)
8. The AUA/SUFU Guideline on Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction (American Urological Association (AUA)/Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU)) Guideline Statements(2021)
9. Philip van Kerrebroeck et al. Combination Therapy with Solifenacin and Tamsulosin Oral Controlled Absorption System in a Single Tablet for Lower

Urinary Tract Symptoms in Men: Efficacy and Safety Results from the Randomised Controlled NEPTUNE Trial. EUROPEAN UROLOGY. 2013;64:1003–1012.

10. Marcus J. Drake et al. Long-term Safety and Efficacy of Single-tablet Combinations of Solifenacin and Tamsulosin Oral Controlled Absorption System in Men with Storage and Voiding Lower Urinary Tract Symptoms: Results from the NEPTUNE Study and NEPTUNE II Open-label Extension. EUROPEAN UROLOGY. 2015;67:262–270

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[339] Vadadustat 경구제 (품명: 바다넴정 150mg 등)	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. -아 래- ○ 투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자의 증후성 빈혈치료 1) 헤모글로블린(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우. (단, 기존에 적혈구 생성 촉진제(erythropoiesis stimulating agents; ESA)로 치료하지 않은 환자는 Hb 10g/dL 미만 또는 Hct 30% 미만인 경우) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL(또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함.	○ Vadadustat (경구제 (품명: 바다넴정 150mg 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

		2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. 3) ESA 제제와의 병용투여는 인정하지 않음.	
※ 관련근거 · FDA (2024.3.), EMA (2023.4.), TGA (2023.10.) · DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12th Edition (2023) · Approaches to Chronic Kidney Disease: A guide for Primary care Providers and Non-Nephrologists (2022) · Applied Peritoneal Dialysis: Improving Patient Outcomes, (2021) · Diabets and Kidney Disease, 2nd Edition (2022) · National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases, Eighth Edition, (2022) · KDIGO 2025 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) PUBLIC REVIEW DRAFT (2024.11.) · Clinical Practice Guideline: Anemia of CKD: UKKA, UK Kidney Association (2024.) · Eckardt et al. Safety and Efficacy of Vadadustat for Anemia in Patients Undergoing Dialysis. N Engl J Med 2021;384:1601-12. DOI: 10.1056/NEJMoa2025956 · Nangaku et al. Efficacy and safety of vadadustat compared with darbepoetin alfa in Japanese anemic patients on hemodialysis: a Phase 3, multicenter, randomized, double-blind study. Nephrol Dial Transplant (2021) 36: 1731-1741 doi: 10.1093/ndt/gfab055 · Nangaku et al. Vadadustat for anemia in chronic kidney disease patients on peritoneal dialysis: A phase 3 open-label study in Japan. Ther Apher Dial. 2021;25:642-653. 목표 Hb농도(11.0~13.0g/dL) · Masaomi Nangaku et al. A phase 3, open-label, single-arm study of vadadustat for anemia in chronic kidney disease for Japanese patients on hemodialysis not receiving erythropoiesis-stimulating agents. Ther Apher Dial. 2022;26:45-54. 목표 Hb농도(11.0~12.0g/dL) · Qiong Huang et al. Comparative effectiveness and acceptability of HIF prolyl-hydroxylase inhibitors versus for anemia patients with chronic kidney disease undergoing dialysis: a systematic review and network meta-analysis. Front. Pharmacol. 2023. 14:1050412. · HIF-PHD inhibitors(roxadustat, vadadustat, daprodustat, enarodustat, molidustat, desidustat), ESAs (rhEPO, DPO, MPG-EPO) · NICE (2025.1.)			

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[399] Dantrolene 주사제 (품명: 아길러스주 120mg 등)	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함. ※ 식품의약품안전처장의 인정범위 - 악성고열증(성인 및 소아)	○ 미허가 긴급도입의약품으로 교과서, 관련 학회의견 및 임상논문 등을 참조하여 식품의약품안전청장이 인정한 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함.
※ 관련근거 · Katzung's Basic & Clinical Pharmacology, 16e · Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11e · Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e · Glahn et al. Recognition and management of a malignant hyperthermia crisis: updated 2024 guideline from the European Malignant Hyperthermia Group(EMHG) · Hopkins et al. Malignant hyperthermia 2020: Guideline from the Association of Anaesthetists. Anaesthesia. 2021; 76(5): 655-664 · Wappler F. S1-Leitlinie maligne Hyperthermie: update 2018. Der Anaesthesist. 2018;67(7):529-532 · Malignant Hyperthermia Association of the United States(MHAUS) · Toyota Y et al, Rapid Dantrolene Administration with Body Temperature Monitoring Is Associated with Decreased Mortality in Japanese Malignant Hyperthermia Events. Biomed Res Int. 2023;2023:8340209 · Sánchez-Molina et al, Malignant Hyperthermia Syndrome: A Clinical Case Report, EJIFCC. 2021;32(2):286-291 · Lee at al. A case of malignant hyperthermia during anesthesia induction with sevoflurane -A case report Korean J Anesthesiol 2010; 59: S6-S8 · G Islander. Dantrolene in the treatment of malignant hyperthermia: a case report, BMC Anesthesiology, 2014 Aug 18;14(Suppl 1):A7 · HAS · AETNA			

[별지 2]

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준																														
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유																											
	현 행	개 정(안)																												
[일반원칙]	고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함.	고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함.	○ 암부트라프리필드시린 지주 신규 등재에 따른 변경																											
고가의약품 급여관리에 관한 기준	- 아 래 -	- 아 래 -																												
	<table><tr><th>약제명</th><th>관리 기간</th><th>비고</th></tr><tr><td>김리아주(Tisag enlecleucel)</td><td>1년</td><td>비호지킨림프종에 투여한 경우</td></tr><tr><td>졸겐스마주(On asemnogene abeparvovec)</td><td>5년</td><td>-</td></tr><tr><td>스핀라자주 (Nusinersen sodium)</td><td>1년</td><td rowspan="2">첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우</td></tr><tr><td>에브리스디건조</td><td>1년</td></tr></table>	약제명		관리 기간	비고	김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우	졸겐스마주(On asemnogene abeparvovec)	5년	-	스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우	에브리스디건조	1년	<table><tr><th>약제명</th><th>관리 기간</th><th>비고</th></tr><tr><td>김리아주(Tisag enlecleucel)</td><td>1년</td><td>비호지킨림프종에 투여한 경우</td></tr><tr><td>졸겐스마주(On asemnogene abeparvovec)</td><td>5년</td><td>-</td></tr><tr><td>스핀라자주 (Nusinersen sodium)</td><td>1년</td><td rowspan="2">첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우</td></tr><tr><td>에브리스디건</td><td>1년</td></tr></table>	약제명	관리 기간	비고	김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우	졸겐스마주(On asemnogene abeparvovec)	5년	-	스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우	에브리스디건
약제명	관리 기간	비고																												
김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우																												
졸겐스마주(On asemnogene abeparvovec)	5년	-																												
스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우																												
에브리스디건조	1년																													
약제명	관리 기간	비고																												
김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우																												
졸겐스마주(On asemnogene abeparvovec)	5년	-																												
스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우																												
에브리스디건	1년																													

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준						
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)			사유		
	현 행		개 정(안)			
	시럽 등(Risdipnam)			조시럽 등(Risdipnam)		
	렉스터나주 (Voretigene neparvovec)	4년	-	렉스터나주 (Voretigene neparvovec)	4년	-
	과지바주 (Dinutuximab beta)	3년	고위험군에 투여한 경우	과지바주 (Dinutuximab beta)	3년	고위험군에 투여한 경우
		2년	재발성·불응성에 투여한 경우		2년	재발성·불응성에 투여한 경우
	빌베이캡슐 (Odevixibat)	1년	-	빌베이캡슐 (Odevixibat)	1년	-
	리브말리엑 (Maralixibat)	5년	-	리브말리엑 (Maralixibat)	5년	-
	<신 설>			암부트라프리 필드시린지주 (Vutrisiran)	1년 6개월	-

[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제	각 약제의 허가사항 범위(폐동맥고혈압) 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 단독요법 각 약제*의 급여기준 범위(대상환자 및 투여방법 등) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함. 나. 병용요법 1) 2제 요법 단독요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때(다음의 ①~④항 소견 중 최소 1개와 ⑤~⑨항 중 최소 1개를 모두 만족), 작용기전이 다른 약제* 1종을 추가한 병용요법을 인정함.	각 약제의 허가사항 범위(폐동맥고혈압) 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 단독요법 각 약제*의 급여기준 범위(대상환자 및 투여방법 등) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함. 나. 병용요법 1) 2제 요법 단독요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때(다음의 ①~④항 소견 중 최소 1개와 ⑤~⑨항 중 최소 1개를 모두 만족), 작용기전이 다른 약제* 1종을 추가한 병용요법을 인정함.	○ 'Macitentan + Tadalafil' 복합정구제(품명 : 읍신비정)*가 신규 등재 예정임에 따라, 급여기준에 해당 성분명을 추가함.

[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	2) 3제 요법 상기 1)의 2제 요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때(다음의 ①~④항 소견 중 최소 1개와 ⑤~⑨항 중 최소 1개를 모두 만족), 2제 요법에서 사용되지 않은 작용기전이 다른 약제* 1종을 추가한 순차적 병용투여(sequential combination)를 인정함. 3) PDE5i계를 포함한 병용요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때(다음의 ①~④항 소견 중 최소 1개와 ⑤~⑨항 중 최소 1개를 모두 만족) PDE5i계를 sGC계로 교체투여 가능하며, PDE5i계와 sGC계의 병용투여는 인정하지 아니함. - 다 음 -	2) 3제 요법 상기 1)의 2제 요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때(다음의 ①~④항 소견 중 최소 1개와 ⑤~⑨항 중 최소 1개를 모두 만족), 2제 요법에서 사용되지 않은 작용기전이 다른 약제* 1종을 추가한 순차적 병용투여(sequential combination)를 인정함. 3) PDE5i계를 포함한 병용요법으로 3개월 이상 투여 후 임상적 반응이 충분하지 않을 때(다음의 ①~④항 소견 중 최소 1개와 ⑤~⑨항 중 최소 1개를 모두 만족) PDE5i계를 sGC계로 교체투여 가능하며, PDE5i계와 sGC계의 병용투여는 인정하지 아니함. - 다 음 -	

[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유																																								
	현 행	개 정(안)																																									
	<table><tr><th>지표</th><th>기준</th></tr><tr><td>① 우심실부전의 임상적 증거(clinical evidence of RV failure)</td><td>있음</td></tr><tr><td>② 증상진행의 속도(Rate of progression of symptoms)</td><td>빠름</td></tr><tr><td>③ 실신(Syncope)</td><td>있음</td></tr><tr><td>④ WHO 기능분류(WHO-FC)</td><td>III 단계 이상</td></tr><tr><td>⑤ 6분 보행거리(6MWT)</td><td>440m 이하</td></tr><tr><td>⑥ 운동부하심폐검사 (Cardio-pulmonary exercise testing)</td><td>Peak O₂ consumption ≤ 15mL/min/kg</td></tr><tr><td>⑦ BNP/NT-proBNP plasma levels</td><td>50/300 이상</td></tr><tr><td>⑧ 심초음파검사소견 (Echocardiographic findings)</td><td>Pericardial effusion 또는 TAPSE<1.5cm</td></tr><tr><td>⑨ 혈류역학검사지표(Hemodynamics)</td><td>RAP ≥ 8mmHg 또는 CI<2.5L/min/m²</td></tr></table> 4) 1)에 명시한 단독요법의 투여 기간(3개월)을 충족하지 않더라도 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에는 투여소견서 첨부 시 사례별로 신속한(또는 초기) 2제 병용 요법을 인정함. - 다 음 -	지표	기준	① 우심실부전의 임상적 증거(clinical evidence of RV failure)	있음	② 증상진행의 속도(Rate of progression of symptoms)	빠름	③ 실신(Syncope)	있음	④ WHO 기능분류(WHO-FC)	III 단계 이상	⑤ 6분 보행거리(6MWT)	440m 이하	⑥ 운동부하심폐검사 (Cardio-pulmonary exercise testing)	Peak O ₂ consumption ≤ 15mL/min/kg	⑦ BNP/NT-proBNP plasma levels	50/300 이상	⑧ 심초음파검사소견 (Echocardiographic findings)	Pericardial effusion 또는 TAPSE<1.5cm	⑨ 혈류역학검사지표(Hemodynamics)	RAP ≥ 8mmHg 또는 CI<2.5L/min/m ²	<table><tr><th>지표</th><th>기준</th></tr><tr><td>① 우심실부전의 임상적 증거(clinical evidence of RV failure)</td><td>있음</td></tr><tr><td>② 증상진행의 속도(Rate of progression of symptoms)</td><td>빠름</td></tr><tr><td>③ 실신(Syncope)</td><td>있음</td></tr><tr><td>④ WHO 기능분류(WHO-FC)</td><td>III 단계 이상</td></tr><tr><td>⑤ 6분 보행거리(6MWT)</td><td>440m 이하</td></tr><tr><td>⑥ 운동부하심폐검사 (Cardio-pulmonary exercise testing)</td><td>Peak O₂ consumption ≤ 15mL/min/kg</td></tr><tr><td>⑦ BNP/NT-proBNP plasma levels</td><td>50/300 이상</td></tr><tr><td>⑧ 심초음파검사소견 (Echocardiographic findings)</td><td>Pericardial effusion 또는 TAPSE<1.5cm</td></tr><tr><td>⑨ 혈류역학검사지표(Hemodynamics)</td><td>RAP ≥ 8mmHg 또는 CI<2.5L/min/m²</td></tr></table> 4) 1)에 명시한 단독요법의 투여 기간(3개월)을 충족하지 않더라도 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에는 투여소견서 첨부 시 사례별로 신속한(또는 초기) 2제 병용 요법을 인정함. - 다 음 -	지표	기준	① 우심실부전의 임상적 증거(clinical evidence of RV failure)	있음	② 증상진행의 속도(Rate of progression of symptoms)	빠름	③ 실신(Syncope)	있음	④ WHO 기능분류(WHO-FC)	III 단계 이상	⑤ 6분 보행거리(6MWT)	440m 이하	⑥ 운동부하심폐검사 (Cardio-pulmonary exercise testing)	Peak O ₂ consumption ≤ 15mL/min/kg	⑦ BNP/NT-proBNP plasma levels	50/300 이상	⑧ 심초음파검사소견 (Echocardiographic findings)	Pericardial effusion 또는 TAPSE<1.5cm	⑨ 혈류역학검사지표(Hemodynamics)	RAP ≥ 8mmHg 또는 CI<2.5L/min/m ²	
지표	기준																																										
① 우심실부전의 임상적 증거(clinical evidence of RV failure)	있음																																										
② 증상진행의 속도(Rate of progression of symptoms)	빠름																																										
③ 실신(Syncope)	있음																																										
④ WHO 기능분류(WHO-FC)	III 단계 이상																																										
⑤ 6분 보행거리(6MWT)	440m 이하																																										
⑥ 운동부하심폐검사 (Cardio-pulmonary exercise testing)	Peak O ₂ consumption ≤ 15mL/min/kg																																										
⑦ BNP/NT-proBNP plasma levels	50/300 이상																																										
⑧ 심초음파검사소견 (Echocardiographic findings)	Pericardial effusion 또는 TAPSE<1.5cm																																										
⑨ 혈류역학검사지표(Hemodynamics)	RAP ≥ 8mmHg 또는 CI<2.5L/min/m ²																																										
지표	기준																																										
① 우심실부전의 임상적 증거(clinical evidence of RV failure)	있음																																										
② 증상진행의 속도(Rate of progression of symptoms)	빠름																																										
③ 실신(Syncope)	있음																																										
④ WHO 기능분류(WHO-FC)	III 단계 이상																																										
⑤ 6분 보행거리(6MWT)	440m 이하																																										
⑥ 운동부하심폐검사 (Cardio-pulmonary exercise testing)	Peak O ₂ consumption ≤ 15mL/min/kg																																										
⑦ BNP/NT-proBNP plasma levels	50/300 이상																																										
⑧ 심초음파검사소견 (Echocardiographic findings)	Pericardial effusion 또는 TAPSE<1.5cm																																										
⑨ 혈류역학검사지표(Hemodynamics)	RAP ≥ 8mmHg 또는 CI<2.5L/min/m ²																																										

- 15 -

[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유								
	현 행	개 정(안)									
	가) 인정 가능 2제 병용 조합 · PDE5i계+ ERA계 <u>〈추 가〉</u> · Treprostinil 주사제+ ERA계 · Treprostinil 주사제+ PDE5i계 나) 대상환자 우심도자를 통해 폐동맥고혈압이 확진*되고, WHO 기능분류 단계 IV에 해당하면서, 아래의 지표 중 한 개 이상을 만족하는 경우 * 환자의 상태로 인해 우심도자 검사가 불가능한 경우, 심초음파 검사 상 ‘peak tricuspid regurgitation velocity >3.4(m/s)’ 등 폐동맥고혈압을 확실히 의심할 수 있는 경우를 포함함 - 아 래 - <table><tr><th>지표</th><th>기준</th></tr><tr><td>6분 보행거리(6MWD)</td><td>165m 미만</td></tr></table>	지표	기준	6분 보행거리(6MWD)	165m 미만	가) 인정 가능 2제 병용 조합 · PDE5i계+ ERA계 <u>(Tadalafil+ Macitentan 복합제 포함)</u> · Treprostinil 주사제+ ERA계 · Treprostinil 주사제+ PDE5i계 나) 대상환자 우심도자를 통해 폐동맥고혈압이 확진*되고, WHO 기능분류 단계 IV에 해당하면서, 아래의 지표 중 한 개 이상을 만족하는 경우 * 환자의 상태로 인해 우심도자 검사가 불가능한 경우, 심초음파 검사 상 ‘peak tricuspid regurgitation velocity >3.4(m/s)’ 등 폐동맥고혈압을 확실히 의심할 수 있는 경우를 포함함 - 아 래 - <table><tr><th>지표</th><th>기준</th></tr><tr><td>6분 보행거리(6MWD)</td><td>165m 미만</td></tr></table>	지표	기준	6분 보행거리(6MWD)	165m 미만	
지표	기준										
6분 보행거리(6MWD)	165m 미만										
지표	기준										
6분 보행거리(6MWD)	165m 미만										

- 16 -

[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제																				
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유																	
	현 행	개 정(안)																		
	<table> <tr> <td>운동부하심폐검사(Cardiopulmonary exercise testing)</td> <td> Peak $VO_2 < 11 \text{ ml/min/kg} (< 35 \% \text{ pred.})$ $VE/VCO_2 \text{ slope} \geq 45$ </td> </tr> <tr> <td>NT-proBNP plasma levels</td> <td> $BNP > 300 \text{ ng/l}$ $NT\text{-proBNP} > 1400 \text{ ng/l}$ </td> </tr> <tr> <td>Imaging(echocardiography, CMR imaging)</td> <td> $RA \text{ area} > 26 \text{ cm}^2$ Pericardial effusion </td> </tr> <tr> <td>혈류역학검사지표(Hemodynamics)</td> <td> $RAP > 14 \text{ mmHg}$ $CI < 2.0 \text{ l/min/m}^2$ $SvO_2 < 60 \%$ </td> </tr> </table>	운동부하심폐검사(Cardiopulmonary exercise testing)	Peak $VO_2 < 11 \text{ ml/min/kg} (< 35 \% \text{ pred.})$ $VE/VCO_2 \text{ slope} \geq 45$	NT-proBNP plasma levels	$BNP > 300 \text{ ng/l}$ $NT\text{-proBNP} > 1400 \text{ ng/l}$	Imaging(echocardiography, CMR imaging)	$RA \text{ area} > 26 \text{ cm}^2$ Pericardial effusion	혈류역학검사지표(Hemodynamics)	$RAP > 14 \text{ mmHg}$ $CI < 2.0 \text{ l/min/m}^2$ $SvO_2 < 60 \%$	<table> <tr> <td>운동부하심폐검사(Cardiopulmonary exercise testing)</td> <td> Peak $VO_2 < 11 \text{ ml/min/kg} (< 35 \% \text{ pred.})$ $VE/VCO_2 \text{ slope} \geq 45$ </td> </tr> <tr> <td>NT-proBNP plasma levels</td> <td> $BNP > 300 \text{ ng/l}$ $NT\text{-proBNP} > 1400 \text{ ng/l}$ </td> </tr> <tr> <td>Imaging(echocardiography, CMR imaging)</td> <td> $RA \text{ area} > 26 \text{ cm}^2$ Pericardial effusion </td> </tr> <tr> <td>혈류역학검사지표(Hemodynamics)</td> <td> $RAP > 14 \text{ mmHg}$ $CI < 2.0 \text{ l/min/m}^2$ $SvO_2 < 60 \%$ </td> </tr> </table>	운동부하심폐검사(Cardiopulmonary exercise testing)	Peak $VO_2 < 11 \text{ ml/min/kg} (< 35 \% \text{ pred.})$ $VE/VCO_2 \text{ slope} \geq 45$	NT-proBNP plasma levels	$BNP > 300 \text{ ng/l}$ $NT\text{-proBNP} > 1400 \text{ ng/l}$	Imaging(echocardiography, CMR imaging)	$RA \text{ area} > 26 \text{ cm}^2$ Pericardial effusion	혈류역학검사지표(Hemodynamics)	$RAP > 14 \text{ mmHg}$ $CI < 2.0 \text{ l/min/m}^2$ $SvO_2 < 60 \%$		
운동부하심폐검사(Cardiopulmonary exercise testing)	Peak $VO_2 < 11 \text{ ml/min/kg} (< 35 \% \text{ pred.})$ $VE/VCO_2 \text{ slope} \geq 45$																			
NT-proBNP plasma levels	$BNP > 300 \text{ ng/l}$ $NT\text{-proBNP} > 1400 \text{ ng/l}$																			
Imaging(echocardiography, CMR imaging)	$RA \text{ area} > 26 \text{ cm}^2$ Pericardial effusion																			
혈류역학검사지표(Hemodynamics)	$RAP > 14 \text{ mmHg}$ $CI < 2.0 \text{ l/min/m}^2$ $SvO_2 < 60 \%$																			
운동부하심폐검사(Cardiopulmonary exercise testing)	Peak $VO_2 < 11 \text{ ml/min/kg} (< 35 \% \text{ pred.})$ $VE/VCO_2 \text{ slope} \geq 45$																			
NT-proBNP plasma levels	$BNP > 300 \text{ ng/l}$ $NT\text{-proBNP} > 1400 \text{ ng/l}$																			
Imaging(echocardiography, CMR imaging)	$RA \text{ area} > 26 \text{ cm}^2$ Pericardial effusion																			
혈류역학검사지표(Hemodynamics)	$RAP > 14 \text{ mmHg}$ $CI < 2.0 \text{ l/min/m}^2$ $SvO_2 < 60 \%$																			
<u><추 가></u> ※ 대상약제 · ERA계: Ambrisentan 경구제, Bosentan 경구제, Macitentan 경구제 · PDE5i계: Sildenafil 경구제 <u><추 가></u> · sGC계: Riociguat 경구제 · Prostacyclin계: Selexipag 경구제,		<u>다. 복합제는 복합된 성분수의 약제를 부여한 것으로 인정함.</u> ※ 대상약제 · ERA계: Ambrisentan 경구제, Bosentan 경구제, Macitentan 경구제 · PDE5i계: Sildenafil 경구제 · <u>ERA계 + PDE5i계: Macitentan+tadalafil 복합 경구제</u> · sGC계: Riociguat 경구제 · Prostacyclin계: Selexipag 경구제,																		

- 17 -

[일반원칙] 폐동맥고혈압 약제				
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유	
	현 행	개 정(안)		
	Treprostinil 주사제, Iloprost 흡입액	Treprostinil 주사제, Iloprost 흡입액		
※ 관련근거 · ‘Macitentan + Tadalafil 복합경구제 (품명 : 옵신비정)’ 신규 등재(‘26.4.1.)				

[119] 기타의 중추신경용약				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[119] Ocrelizumab 주사제 (품명 : 오크레부스주 <추 가>)	(생 략)	[119] Ocrelizumab 주사제 (품명 : 오크레부스주 등)	(현행과 같음)	○ ‘오크레부스피하주사’가 신규 등재 예정임에 따라 기존 Ocrelizumab 주사제 급여기준과 동일하게 적용하도록 함. 단, 고시 구분의 품명에 ‘등’을 추가하는 것이 적절함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>				

- 18 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Tocilizumab 주사제 (품명 : 악템라주, 악템라피하주사 162 밀리그램 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 라. (생 략) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. 가. ~ 나. (생 략) 다. <u>Tisagenlecleucel(품명: 킴리아주) 투여로 인한 사이토카인 방출 증후군(CRS)의 관리</u> 1) 투여대상 ○ 성인 및 만2세 이상의 소아 2) 투여방법 ○ Tisagenlecleucel(품명: 킴리아주)의 사용상 주의사항 '사이토카인 방출 증후군(CRS)의 관리' 알고리즘에 따름.	1. (현행과 같음) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. <u>사이토카인 방출 증후군(CRS)을 유발하는 약제의 허가사항에 CRS와 IL-6 수용체 억제제(또는 토실리주맵)가 모두 명시된 경우, 다음과 같은 기준에 따라 투여 시 요양급여를 인정함.</u> - 다 음 - 1) 투여대상 다음 가), 나) 조건을 동시에 충족하는 경우 가) <u>성인 및 2세 이상 소아</u>	○ 국내외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 (전문가) 의견 등을 참조하여, 등재 예정인 Epcoritamab(품명: 엠킨리주4mg/0.8mL, 48mg/0.8mL)을 포함해 허가사항에 CRS와 IL-6 수용체 억제제 (또는 Tocilizumab)이 명시된 약제 투여 후 발생한 CRS 관리 목적의 Tocilizumab을 투여하는 경우에 대해 급여기준 확대

- 19 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		나) <u>CRS Grade 2* 이상인 경우</u> * <u>ASTCT(American Society for Transplantation and Cellular Therapy) 기준 적용</u> 2) 투여용량 가) <u>체중 30kg 이상: 8mg/kg (최대용량 800mg)</u> 나) <u>체중 30kg 미만: 12mg/kg</u> 3) 재투여방법 ○ <u>증상 호전이 없는 경우, CRS를 유발한 약제의 허가사항에 기재된 CRS 관리 지침 등에 따라 재투여를 인정함</u> ○ <u>단, 허가사항에 재투여 관련 내용이 명시되어 있지 않는 경우, 최소 8시간 간격으로 최대 3회까지 추가 투여 가능함(총 4회까지 투여 가능)</u>	
	3. ~ 6. (생 략)	3. ~ 6. (현행과 같음)	

※ 관련근거

- 식품의약품안전처 허가사항

- 20 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
- Harrison’s Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 71: Oncologic Emergencies - Hematology: Basic Principles and Practice, 8e, 2023> Chapter 96: Grading and Toxicity Management after Immune Effector Therapy - Manual of Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapies, 2024> Cytokine Release Syndrome Following CD19 Directed Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy - The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook 1e, 2022 > 26. Management of Cytokine Release Syndrome (CRS) and HLH - Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice 10e, 2023 > Chapter. Oncologic Emergencies - ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells 2019 - NCCN guideline 2025 > Management of CAR T-Cell and Lymphocyte Engager-Related Toxicities] - ASCO Guideline 2021 > Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy - Common Terminology Criteria for Adverse Events(CTCAE) v6.0, 2025 > Immune system disorders - Chimeric antigen receptor T-cell therapy – assessment and management of toxicities, Neelapu SS 2018 January ; 15(1): 47–62. doi:10.1038/nrclinonc.2017.148. - Long-Term Follow-up of CD19 CAR Therapy in Acute Lymphoblastic Leukemia Locke FL, et. al. N Engl J Med. 2018 February 01; 378(5): 449–459. doi:10.1056/NEJMoal709919 - (ESMO) Solid tumour cellular therapy d principles of toxicity management M.Julve et. al 2025 Volume 25, https://doi.org/10.1016/j.iotech.2024.100737			

[219] 기타의 순환계용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	

[219] 기타의 순환계용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[219] Tafamidis 경구제 (품명: 빈다맥스캡슐 61밀리그램)	1. (생 략) <u><추 가></u> 2. 동 약제는 심장 관련 진료과 전문의가 처방하여야 하며 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(의무기록지, 유전자검사결과지, 심장초음파 및 핵의학검사결과지, 조직 검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함.	1. (현행과 같음) 2. <u>Vutrisiran sodium주사제(품명:암부트라프리필드시린지주)와 병용투여는 인정하지 아니함.</u> 3. 동 약제는 심장 관련 진료과 전문의가 처방하여야 하며 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(의무기록지, 유전자검사결과지, 심장초음파 및 핵의학검사결과지, 조직 검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함.	○ Vutrisiran sodium 주사제(품명 : 암부트라프리필드시린지주)가 신규 등재 예정임에 따라, 병용투여 금기 사항을 추가함.
※ 관련근거 · Vutrisiran sodium주사제(품명:암부트라프리필드시린지주) 신규 등재('26.4.1.)			

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
[249] Darbepoetin alpha 주사제 (품명: 네스프프리필 드시린지주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담 토록 함. - 아 래 - 가. 만성신부전 환자의 빈혈치료(철결핍성 빈혈로 진단된 환자는 제외함) 1) 헤모글로블린(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우 (투석을 받고 있지 않는 환자는 사구 체여과율(GFR) 30mL/min/1.73m ² 미 만인 환자에 한함) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투 여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL (또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함. 2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담 토록 함. - 아 래 - 가. 만성신부전 환자의 빈혈치료(철결핍성 빈혈로 진단된 환자는 제외함) 1) 헤모글로블린(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우 (투석을 받고 있지 않는 환자는 사구 체여과율(GFR) 30mL/min/1.73m ² 미 만인 환자에 한함) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투 여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL (또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함. 2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양	○ ‘Vadadustat (경구제 (품명: 바다넵정 150mg 등)’가 신규 등재 예정임에 따라, 병용금기 문구 추가

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매 월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. <추 가> 나. (생 략) 2. (생 략)	급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매 월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. 3) 투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자에서 Vadadustat와 병용투여는 인정하지 않음 나. (현행과 같음) 2. (현행과 같음)	
[249] Erythropoietin 주사제 (품명 : 에포카인주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담 토록 함. - 아 래 - 가. 만성신부전 환자의 빈혈치료(철결핍성 빈혈로 진단된 환자는 제외함) 1) 헤모글로블린(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담 토록 함. - 아 래 - 가. 만성신부전 환자의 빈혈치료(철결핍성 빈혈로 진단된 환자는 제외함) 1) 헤모글로블린(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우	○ ‘Vadadustat (경구제 (품명: 바다넵정 150mg 등)’가 신규 등재 예정임에 따라, 병용금기 문구 추가

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	(투석을 받고 있지 않는 환자는 사구체여과율(GFR) 30mL/min/1.73m² 미만인 환자에 한함) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL (또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함. 2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매 월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. <u><추 가></u> 나. (생 략) 2. (생 략)	(투석을 받고 있지 않는 환자는 사구체여과율(GFR) 30mL/min/1.73m² 미만인 환자에 한함) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL (또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함. 2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매 월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. 3) 투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자에서 Vadadustat와 병용투여는 인정하지 않음 나. (현행과 같음) 2. (현행과 같음)	
[249]	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인	○ 'Vadadustat (경구제 (품명: 바다넵정

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
Methoxy polyethylene glycol-epoetin β 주사제 (품명: 미세라프리필드주)	정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 만성신부전 환자의 빈혈치료(철결핍성 빈혈로 진단된 환자는 제외함) 1) 헤모글로빈(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우 (투석을 받고 있지 않는 환자는 사구체여과율(GFR) 30mL/min/1.73m² 미만인 환자에 한함) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL (또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함. 2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매 월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. <u><추 가></u>	정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 만성신부전 환자의 빈혈치료(철결핍성 빈혈로 진단된 환자는 제외함) 1) 헤모글로빈(Hb) 10g/dL 이하 또는 헤마토크리트(Hct) 30% 이하인 경우 (투석을 받고 있지 않는 환자는 사구체여과율(GFR) 30mL/min/1.73m² 미만인 환자에 한함) - 다만, 동 조건에 해당하여 약제를 투여하다 중단한 경우 Hb 10-11g/dL (또는 Hct 30-33%)의 유지를 위하여 재투여 시 요양급여를 인정함. 2) Hb 11g/dL 또는 Hct 33%까지 요양급여를 인정하며, 진료비 청구 시 매 월별 혈액검사 결과치를 첨부하여야 함. 3) 투석을 받고 있는 만성 신질환 성인	150mg 등)'가 신규 등재 예정임에 따라, 병용금지 문구 추가

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>환자에서 Vadadustat와 병용투여는 인정하지 않음</u>	
	2. (생 략)	2. (현행과 같음)	
※ 관련근거 · ‘Vadadustat (경구제 (품명: 바다넵정 150mg 등)’ 신규 등재(‘26.4.1.)			

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[439]	(생 략)	[439]	(현행과 같음)	○ ‘바비스모프리필드 시린지주’가 신규 등재 예정임에 따라, 기존 Faricimab 주사제 급여기준과 동
Faricimab 주사제		Faricimab 주사제		

- 27 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
(품명: 바비스모주 <추 가>)		(품명: 바비스모주 등)		일하게 적용하도록 함. 단, 고시 구분의 품명에 ‘등’을 추가 하는 것이 적절함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>				

- 28 -